認識心肌梗塞

血管突然被血栓塞住，心肌正在壞死——每一分鐘都算數

看懂症狀、知道要打 119、了解治療與復健

掃描看電子版

什麼是心肌梗塞？有什麼症狀？

斑塊破裂 → 血栓塞住 → 心肌開始壞死



典型症狀——持續超過 5 分鐘不會自己好



特別注意：女性、長輩、糖尿病人常不會胸痛，可能只覺得喘、累、噁心或上腹悶，容易被當成胃病而延誤。

誰的風險高？

紅＝可以改變　灰＝不能改變，但更要控制其他項目



有多危險？

時間就是心肌——越晚打通，壞死越多、心臟功能掉越多

前幾小時	90 分鐘	不要自己開車
最危險的時段 可能突發致命心律不整	到院後打通血管的目標 台灣的照護品質指標	路上失去意識會更糟 救護車上就能做心電圖

醫師會怎麼治療？

首選是**緊急心導管**，把塞住的血管盡快打通

緊急心導管（主要做法）

從手腕或鼠蹊部放入導管，找到塞住的地方
抽出血栓、以氣球撐開，多數會放支架固定
健保全額給付傳統支架；塗藥支架需自付差額

出院後的藥一定要吃

兩種抗血小板藥**至少吃滿一年**，自行停藥
可能造成支架內急性血栓，後果嚴重
另有降血脂等長期用藥；乙型阻斷劑依心臟功能決定

什麼時候能回到原本的生活？

以下為一般情況，實際請由醫師依您的心臟功能決定

走路	開車	性生活	回去上班	勞力工作
出院後就開始	約 1~2 週	約 3 週	多數 1~3 個月	需個別評估

職業駕駛另有規定；裝有去顫器或心臟功能較差者，上述時間都會不同。

心臟復健：不是多休息，是要動起來

可降低再梗塞與死亡率

第一期　住院中	第二期　出院後	第三期　長期
下床、走動，減少臥床併發症	醫院監測下的運動訓練，健保有療程	把運動變成生活習慣，自己維持

! 出現這些情況，立刻打 119

胸口壓迫或悶痛超過 5 分鐘不緩解　·　含了硝化甘油仍沒有改善　·　冒冷汗、喘不過氣、快要昏倒

不要自己開車、不要等家人載——救護車上就能做心電圖並事先通知醫院準備，比你自己到院快得多。

資料來源（查核至 2026 年 10 月）

2025 ACC/AHA 急性冠心症處置指引　·　中華民國心臟學會急性冠心症相關指引

健保署急性心肌梗塞醫療品質資訊　·　國健署心血管疾病防治資料

· © 2026 林祐騰醫師 編製　未經同意請勿重製